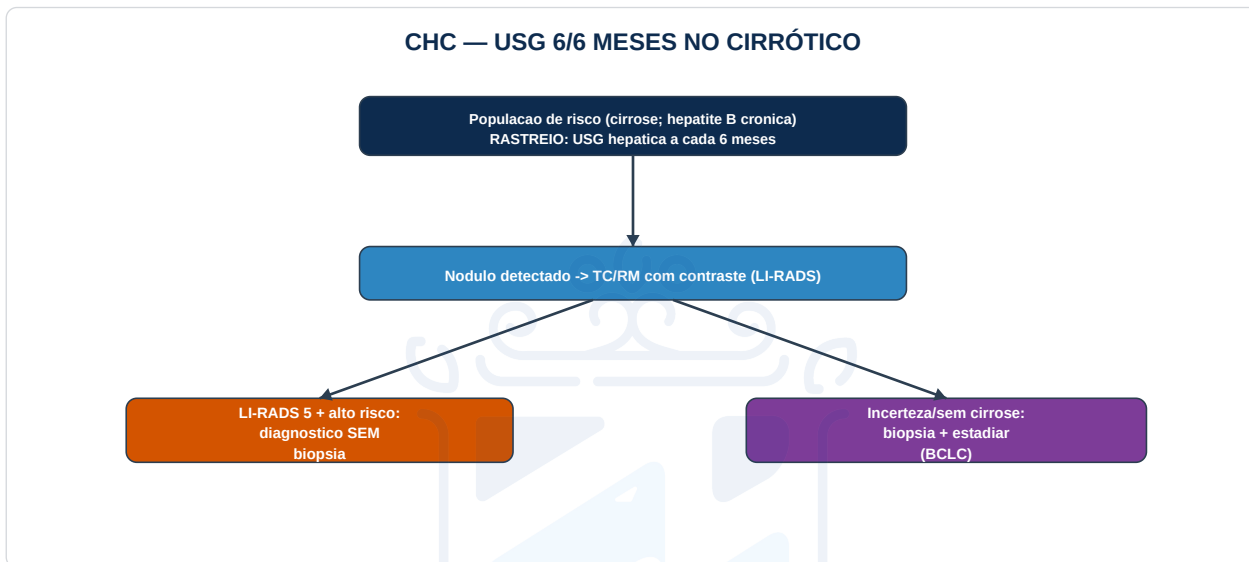


CARCINOMA HEPATOCELULAR — RASTREIO E DX

FLUXOGRAMA — RASTREIO E DIAGNÓSTICO



DEFINIÇÃO E FATORES DE RISCO

O QUE É

- Câncer hepático PRIMÁRIO mais prevalente (colangiocarcinoma é o 2º; metástases — sobretudo de cólon/reto — são as lesões mais comuns no geral)
- Principais fatores de risco: CIRROSE (qualquer etiologia) e infecção crônica pelo vírus da HEPATITE B (mesmo sem cirrose)
- Outros: hepatite C, esteato-hepatite (NASH), álcool, hemocromatose
- Diagnóstico precoce permite terapia curativa (sobrevida em 5 anos até 70%)

QUANDO SUSPEITAR — MANIFESTAÇÕES

FREQUENTEMENTE ASSINTOMÁTICO

- Descompensação de cirrose: ascite, encefalopatia, piora da icterícia/hipertensão portal (pouca tolerância à infiltração tumoral)
- Acometimento local: icterícia obstrutiva, rotura tumoral com hemoperitônio, abscesso hepático
- Síndromes paraneoplásicas: HIPOGLICEMIA, hipercalcemia, alterações dermatológicas (dermatomiosite, pênfigo foliáceo, sinal de Leser-Trélat)
- Muitos pacientes não têm sintomas específicos — daí a importância do rastreio
- No PS: pensar em CHC no cirrótico que descompensa sem causa clara

RASTREAMENTO

QUEM E COMO

- Indicação: pacientes com CIRROSE (maioria das diretrizes); hepatite B crônica conforme risco (ex.: ferramenta PAGE-B)
- Exame de escolha: USG hepática a cada 6 MESES (TC de abdome se USG tecnicamente difícil)
- Alfa-fetoproteína: papel CONTROVERSO — nunca isolada; com USG aumenta a detecção em ~10%
- Lesões benignas/sem lesão: repetir USG em 6 meses
- O rastreio aumenta a chance de terapia curativa e a sobrevida

DIAGNÓSTICO — IMAGEM E LI-RADS

Método	Papel
TC com contraste	Pouco sensível para < 2 cm; VPP até 92% para ≥ 2 cm em candidatos a transplante
RM com contraste	Possivelmente mais acurada que a TC; gadolínio com cautela se ClCr < 30; gadoxetato não usar se bilirrubina > 3
USG com contraste	Caracteriza nódulo já visto; se suspeita de CHC, seguir com TC/RM
LI-RADS 5 + alto risco	Diagnóstico de CHC SEM biópsia (≥ 2 cm com 1 característica; ou 1-2 cm com washout ou crescimento ≥ 50% em 6 meses)

QUANDO BIÓPSIAR

BIÓPSIA RESERVADA

- Em geral a IMAGEM diagnóstica o CHC (LI-RADS 5 em alto risco dispensa biópsia)
- Biópsia se: incerteza diagnóstica ou quando muda a conduta
- Indicação de terapia locorregional (ablação) ou transplante em caso duvidoso
- Suspeita de outro tumor (colangiocarcinoma, metástase)
- AUSÊNCIA de cirrose (LI-RADS validado para alto risco)

TRATAMENTO (visão geral — BCLC)

DEPENDE DO ESTÁGIO E DA FUNÇÃO HEPÁTICA

- Curativos: RESSECÇÃO tumoral e TRANSPLANTE hepático; ablação em estágio inicial
- Locorregionais: ablação, quimioembolização transarterial (TACE), radioembolização
- Sistêmicos: terapia-alvo, IMUNOTERAPIA, quimioterapia
- Algoritmo BCLC integra estágio do tumor, função hepática (Child) e performance status
- Manejo por equipe multidisciplinar (hepatologia, cirurgia, oncologia, radiologia intervencionista)

MODELO DE ENCAMINHAMENTO

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente com fator de risco (cirrose/hepatite B) e nódulo hepático ____ cm; LI-RADS ____.
- Alfa-fetoproteína ____; função hepática (Child) ____; descompensação: ____.
- Conduta: TC/RM com contraste para caracterização; biópsia se indicada.
- Encaminhamento à hepatologia/oncologia (estadiamento BCLC e definição de terapia curativa x paliativa).

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual é o exame e o intervalo de escolha para rastreamento de CHC no paciente cirrótico?

- A) TC de abdome anual
- B) Ultrassonografia hepática a cada 6 meses
- C) Alfa-fetoproteína isolada mensal
- D) Ressonância anual
- E) Biópsia hepática semestral

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Quais são os principais fatores de risco para carcinoma hepatocelular?

- A) Hipertensão e diabetes
- B) Cirrose (qualquer etiologia) e infecção crônica pelo vírus da hepatite B
- C) Tabagismo isolado
- D) Litíase biliar
- E) Refluxo gastroesofágico

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Sobre a alfa-fetoproteína no rastreamento de CHC, é correto:

- A) Deve ser usada isoladamente como rastreio
- B) Tem papel controverso; nunca isolada, mas associada à USG aumenta a detecção (~10%)
- C) É diagnóstica isoladamente
- D) Substitui a ultrassonografia
- E) Não tem qualquer valor

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Em qual situação o CHC pode ser diagnosticado SEM biópsia?

- A) Qualquer nódulo hepático
- B) Lesão LI-RADS 5 em paciente de alto risco (achados típicos de CHC à imagem com contraste)
- C) Sempre é necessária biópsia
- D) Apenas se alfa-fetoproteína normal
- E) Somente em pacientes sem cirrose

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Quais são as terapias com intenção CURATIVA no CHC?

- A) Apenas quimioterapia
- B) Ressecção tumoral e transplante hepático (e ablação em estágio inicial)
- C) Somente quimioembolização
- D) Apenas imunoterapia
- E) Radioterapia exclusiva

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

O rastreamento de CHC no cirrótico é feito com USG hepática a cada 6 meses (TC se USG difícil). Detecta lesões em fase precoce, aumentando a chance de terapia curativa e a sobrevida.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Os principais fatores de risco são a cirrose (qualquer etiologia) e a hepatite B crônica (que pode causar CHC mesmo sem cirrose). Hepatite C, NASH e álcool também contribuem.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A alfa-fetoproteína tem papel controverso: nunca deve ser usada isoladamente para rastreio, mas associada à USG aumenta a taxa de detecção em cerca de 10%.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Em paciente de alto risco com lesão LI-RADS 5 (achados típicos à imagem com contraste — washout, cápsula, crescimento), o CHC é diagnosticado sem biópsia. A biópsia fica para incerteza ou ausência de cirrose.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

As terapias curativas do CHC são a ressecção tumoral e o transplante hepático, além da ablação em estágio inicial. TACE, terapia sistêmica e imunoterapia controlam a doença em estágios mais avançados.

SM24
Suporte ao Plantão Médico